

Alpha Blockers (प्रोस्टेट / मूत्र प्रवाह के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · मूत्र प्रवाह सुधारने वाली दवाएँ

Alpha blockers ऐसी दवाएँ हैं जो प्रोस्टेट और मूत्राशय की गर्दन की मांसपेशी को ढीला करती हैं ताकि पेशाब करना आसान हो — बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) के लक्षणों के लिए यह आमतौर पर पहली दवा होती है। सामान्य दवाएँ हैं **tamsulosin (Flomax)**, **alfuzosin**, **silodosin**, **doxazosin**, और **terazosin**। ये जल्दी असर करती हैं लेकिन प्रोस्टेट को सिकोड़ती नहीं।

यह कैसे काम करती है

बड़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग को दबाता है। Alpha blockers **मूत्राशय की गर्दन की मांसपेशी को ढीला** करती हैं, जिससे पेशाब की धार मज़बूत होती है और रुकावट, जोर लगाना, और बार-बार रुकना कम होता है। ये **लक्षणों** का इलाज करती हैं — प्रोस्टेट का आकार नहीं बदलती, इसलिए दवा लेते रहने तक ही फ़ायदा रहता है।

क्या उम्मीद करें

- सुधार आमतौर पर **जल्दी** होता है — कुछ दिनों से 1–2 हफ़्तों में।
- अक्सर **दिन में एक बार** ली जाती है; tamsulosin हर दिन **एक ही भोजन के लगभग 30 मिनट बाद** लें।
- Doxazosin/terazosin **सोते समय** शुरू की जाती हैं और चक्कर कम करने के लिए धीरे-धीरे बढ़ाई जाती हैं।
- बड़े प्रोस्टेट के लिए इन्हें प्रोस्टेट सिकोड़ने वाली दवा के साथ भी लिया जा सकता है।

शब्दों को समझें

Alpha blocker

मूत्राशय की गर्दन की मांसपेशी को ढीला करने वाली दवा।

BPH

बड़ा हुआ प्रोस्टेट (benign prostatic hyperplasia)।

Bladder neck

मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच की मांसपेशीय गर्दन।

प्रतिगामी वीर्यपात

वीर्य मूत्राशय में वापस जाना — हानिरहित लेकिन कम/बिना द्रव के।

Orthostatic hypotension

खड़े होने पर रक्तचाप गिरने से चक्कर आना।

IFIS

मोतियाबिंद सर्जरी में आँख की पुतली का ढीला होना — अपने आँख के डॉक्टर को बताएँ।

मोतियाबिंद की सर्जरी करवा रहे हैं? अपने आँख के डॉक्टर को बताएँ कि आप alpha blocker लेते हैं (या कभी ली है) — इससे सर्जरी के दौरान आँख की पुतली "ढीली" हो सकती है (IFIS), और वे उसके लिए तैयारी करेंगे। यह **दवा बंद करने के बाद भी** ज़रूरी है।

कैसे लें

- हर दिन **एक ही समय पर** लें (tamsulosin भोजन के ~30 मिनट बाद)।
- Doxazosin/terazosin की **पहली खुराक सोते समय** लें और धीरे-धीरे उठें — पहली खुराक में रक्तचाप गिर सकता है।
- खुराक छूट जाए तो दोगुना न लें।

ज़रूरी सुरक्षा

- **धीरे-धीरे उठें**, खासकर शुरुआत में, ताकि चक्कर या बेहोशी न आए।
- **PDE5 inhibitors** या रक्तचाप की दवाओं के साथ सावधानी बरतें (अधिक चक्कर हो सकते हैं)।
- **प्रतिगामी वीर्यपात** (कम या बिना वीर्यपात) tamsulosin/silodosin में आम है — हानिरहित और दवा बंद करने पर ठीक हो जाता है।

सामान्य दुष्प्रभाव

- चक्कर या हल्कापन; थकान
- बंद नाक
- कम या "सूखा" वीर्यपात

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **बेहोशी** या गंभीर चक्कर
- तेज़ या धड़कती धड़कन, या सीने में दर्द
- **पेशाब बिल्कुल न हो** (तुरंत देखभाल लें)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Alpha blockers BPH में मूत्राशय की गर्दन को जल्दी ढीला करती हैं — लक्षण ठीक होते हैं, प्रोस्टेट नहीं सिकुड़ता।
2. शुरुआत में धीरे उठें (चक्कर) और जानें कि कम/सूखा वीर्यपात सामान्य और हानिरहित है।
3. मोतियाबिंद की सर्जरी से पहले हमेशा **आँख के डॉक्टर** को बताएँ कि आप alpha blocker लेते हैं या ले चुके हैं।